

Fecha Última Actualización: 10-11-2022 8:21:25

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Vicente Guillermo Velasquez Ferrer
Edad : 73a 9m 11d
Dirección : Porvenir 1466 Conj.Monte Grande I

Rut : 5.025.724-K
Fecha Nacto: 23/01/1949
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 0420640
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 1234 5678

N° Epicrisis
300055

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 01/03/2022 11:37

Días Estadía: 247

Unidad de Egreso : Hospital De Campaña - Camas Básic

Fecha Egreso : 03/11/2022 15:07

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Compromiso de consciencia

Comorbilidades

Hipertensión Arterial; AVE;

Procedimientos

17/03/2022 - Traqueotomía Percutánea

Intervenciones Quirúrgicas

Hematoma Intracerebral, Vaciamiento De - 01/03/2022 13:15 - Pedro Ivan Guerrero Bravo

Epidemiología

Resumen Clínico

Antecedentes:

Mórbidos: HTA , ACV secuelado (hemiparesia FC derecha), demencia post ACV.

Quirúrgicos: Hernioplastia, resto desconocidos.

Fármacos: Atorvastatina, Se desconoce resto

Alergias: Niega

Hábitos: no conocido.

Social: Institucionalizado en ELEAM particular Genesis (La Granja)

Inmunizaciones: 2 dosis Sinovac refuerzo Astrazeneca, Flu 2021 (-)

Motivo de Consulta: Agitación

Historia de ingreso:

Al momento del ingreso, se tienen sólo antecedentes de ficha clínica:

Institucionalizado recientemente en ELEAM, con antecedente de ACV previo con secuelas, aparente hemiparesia derecha y posteriormente con deterioro cognitivo sospecha de demencia. Dependiente. Es traído a SU HLF por cuidadores debido a episodio de compromiso de consciencia cualitativo, agitación asociado a déficit motor no caracterizado. Al ingreso en HLF se realiza TC de cerebro que informa hematoma intraparenquimatoso de 9x5x7 cm que no desplaza línea media asociado a signos de hemo ventrículo. En dicho contexto se deriva a HSR para resolución por neurocirugía. Ingres a SU con FC 93, PA103/60, t° 36.4 sat 95% ambiental. Al examen físico con GCS 8, destaca hemiplejía izquierda. Al ingreso dado Glasgow se decide IOT y conexión a VMI. Se deriva de urgencia a drenaje de hematoma. Se realiza craneotomía descompresiva sin incidentes. En dicho contexto ingresa a UPC para continuar manejo.

Diagnósticos de ingreso a UPC:

Compromiso de consciencia secundario

Hematoma intraparenquimatoso cerebral sin desplazamiento de línea media operado.

Antecedentes: ACV secuelado, HTA y Demencia. Paciente institucionalizado.

Evolución durante hospitalización/planes

Hemodinamia: En postoperatorio evoluciona tendiente a la hipotension en relación a sedoanalgesia por lo que se inicia noradrenalina en dosis baja. Se define PAS 180 mmHg, evolucionando hipertenso con requerimientos de rescate de labetalol.

Fecha Epicrisis : 10/11/2022 08:21

Página 1 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:44

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 10-11-2022 8:21:25

Página 2 de 4

Se decide reinicio de vasodilatadores orales con Losartán y BB (Carvedilol) manteniendo hemodinamia autosostenida. Posteriormente evoluciona con cifras tensionales bajas, debido a esto se suspende progresivamente vasodilatadores, Sin requerimiento actual de hipotensores, sin mayores alteraciones en su evolución.

Respiratorio: Ingresa en ventilación mecánica invasiva (VMI) protectora, con weaning lento dado nivel de conciencia e interurrencias infecciosas. Ante lenta recuperación se realiza traqueostomía (TQT) en contexto neurológico, realizada el 16/03, sin complicaciones. Se destete de VMI el 18/03 por lo que se decide traslado a UTIM para continuar manejo. En contexto infeccioso se inicia terapia antimicrobiana con buena respuesta, evolucionando con mejoría en cuanto a disminución de requerimientos de oxígeno hasta lograr suspender. Se mantiene con TQT hasta el 16/04 dado que paciente se autoretira dispositivo, sin lograr recanular, sin embargo, dado que estaba en proceso de decanulación tolerando 8-10 hrs ocluido con buena mecánica y función respiratoria, se decide dejar sin TQT. Con buena evolución posterior, sin requerimientos de O₂, logrando ser efectiva. Respecto a seguimiento imagenológico:

TC de Tórax del 08/03 condensación en lóbulo inferior derecho + hallazgo incidental de moderado enfisema mixto, predominio de segmentos superiores + bula enfisematosa.

TC de Tórax del 22/03/22 persistencia de consolidación basal derecha, impresión en menor cuantía. 05/11 con requerimientos de O₂ 1-2 L transitorios que ceden con aspiración de secreciones. Posteriormente sin nuevas interurrencias en esta área sin presencia de mayores conflictos asociados. Actualmente sin necesidad de uso de O₂ suplementario.

Neurológico: Durante estadía en UPC se mantiene con medidas de protección. Hipertensión permisiva hasta PAS 180, cabeza a 30° euglicemia. Por compromiso de conciencia se solicita: EEG el 09/03 que informa: actividad epileptiforme interictal central derecha. En este contexto se inicia fenitoina como prevención secundaria. Con niveles plasmáticos ajustados por albumina erráticos (Se carga al ingreso UTIM 19/03). Últimos controles infraterapéuticos. Se repite EEG el 22/03 que informa: Sin evidencia de actividad epileptiforme. Frecuente lentitud intermitente anterior derecha, Atenuación de voltaje hemisférica izquierda, Disfunción lenta continua generalizada, reactiva. En contexto de elevación de GGT a pesar de ajuste y carga de niveles de fenitoina, con lentitud intermitente en EEG. Se decide cambio a levetiracetam 500 mg c/12 hrs iniciado el 29/03/22. Sin nuevos episodios convulsivos. Se mantiene con rigidez importante y trastorno del habla, impresión nuevo basal de paciente. Sin embargo mal pronóstico neurológico en contexto de la situación actual del paciente. Actualmente sin nuevos quiebres en esta área, Mutismo y hemiplejía izquierda impresionan ser nuevo basal del paciente. Rigidez en triple flexión.

Quirúrgico: Se realiza drenaje de hematoma frontoparietal derecho el 01/03. Con TC de control adecuado, sin nueva urgencia quirúrgica. Equipo de NeuroCx solicita último TC de control el 21/03, que demuestra prácticamente completa regresión de hematoma operado y regresión de cambios postquirúrgicos, sin aparición de complicaciones sobreagregadas, sin terapias pendientes por parte neurocirugía, de alta de la especialidad. Actualmente estable desde esta parte, sin cambios.

Infeccioso: En postoperatorio evoluciona con aumento progresivo de parámetros inflamatorios, con peak febriles hasta 39°C con regular respuesta a antipiréticos, con cultivo de aspirado endotraqueal (CAET) (+) K. pneumoniae MS. Se realiza punción lumbar, hemática, con cultivo negativo. Se deciden 2 punciones lumbares frustras a pesar de operador experto por lo que se decide cubrir de manera empírica con Meropenem /Vancomicina (FI 07/03) en dosis meníngea. Completa 7 días. Evoluciona con mejoría en curva febril y descenso de parámetros inflamatorios. Se suspende Vancomicina 16/03. Posteriormente evoluciona con nuevo peak febril el mismo día por lo que se pancultiva. De los hemocultivos, resulta HC (+) S. epidermidis con gen mecA/C en panel molecular, sensible a vancomicina, por lo que se inicia cobertura de Vancomicina en dosis bacteremia el 19/03 completando 5 días. El 20/03 nuevamente febril, con aumento de secreciones bronquiales y elevación de parámetros inflamatorios. Se inicia meropenem, persistentemente febril. con hemocultivos periféricos (-), arrastre de CVC (-), sedimento de orina no inflamatorio, UC Polimicrobiano. Se rescata CAET (+) P. aeruginosa y K. pneumoniae multi sensibles. En contexto de estabilidad clínica y cultivo se decide adicionar nebulizaciones con amikacina, con buena respuesta, completando 7 días en total de amikacina + meropenem. Sin nuevo conflicto infeccioso desde marzo, sin embargo actualmente con UPP en pie izquierdo con exposición ósea, se discutió con equipo no realizar intervención quirúrgica, solo manejo médico. En contexto de evaluación del paciente en conjunto con familiares se decide no evaluación por exámenes de laboratorio y no nuevos cultivos en caso de descompensación aguda del paciente. Se ha mantenido estable en la hospitalización sin presencia de nuevos quiebres ni conflictos asociados.

Medio interno: Sin falla renal durante hospitalización. A la realimentación presenta caída de fósforo que se interpreta como Síndrome de realimentación que requirió cargas de monofosfato de potasio. Posteriormente sin conflicto. Además cursa con hiponatremia, se sospecha síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SSIADH), por lo que se solicita TSH y cortisol basal que resultan normales, sin embargo paciente ha respondido a recuperación de natremia sin mayor restricción hídrica ni pastillas de sal, por lo que se descarta SSIADH. Últimos electrolitos normales, con buena función renal se mantiene

Fecha Epicrisis : 10/11/2022 08:21

Página 2 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:44

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 10-11-2022 8:21:25

Página 3 de 4

estable con diuresis conservada.

Rehabilitación: Paciente no conecta, mal pronóstico neurológico. Con apertura ocular espontánea, pero no obedece ordenes. Se mantiene con Kinesioterapia. Además, con trastorno de deglución, el 06/04 se realiza Gastrostomía con buena evolución posterior, se inicia alimentación por gastrostomía el 07/04, sin conflicto actual. Se ha mantenido estable.

Manejo: Dado mal pronóstico neurológico por lo que se determina en conjunto con familiares manejo hasta sala

Diagnósticos de egreso:

Hematoma intraparenquimatoso Frontoparietal derecho con hemo ventrículo de probable causa amiloidea

Compromiso de conciencia secundario

Hemiplejía FBQ izquierda

Trastorno de la deglución GTT instalada el 06/04

Crítico crónico

NAVM CAET (+) KPN MS, tratada con Meropenem + Vancomicina

Bacteremia por S epidermidis mecA/C tratada con Vancomicina

NAAS CAET (+) PSAE y KPN MS tratada con Meropenem EV y Amikacina NBZ

Síndrome de realimentación resuelto

DILI por Fenitoina Resuelto patrón mixto

Hiponatremia Leve asintomática resuelta

Dermatitis del pañal resuelta

LPP Sacra, trocater izq pie izq

Antecedentes: HTA, Demencia Vascular, Institucionalizado.

Caso Social

Diagnóstico de Egreso

Hemorragia Intracerebral En Hemisferio, Cortical - Hematoma Intraparenquimatoso Cerebral Sin Desplazamiento De Línea Media Operado.

Condición de Egreso Alta Otro Destino

Egreso con Catéter Doble J: NO

Paciente estable dentro de su condición, hemodinámicamente estable, afebril, sin requerimientos de O2 suplementario.

Alimentándose por GTT bien tolerado. Diuresis (+), deposiciones (+).

Dependencia severa, LPP en curaciones, con GTT, requiere baño por 3eros, sin movilización.

Plan Post Alta

Indicaciones al alta

Reposo semisentado, cabeza a 30°

Régimen Diben 70 cc/hora por gastrostomía o papilla + agua por gastrostomía

Activación por KNT

Cambio de posición y curación de escaras

Prevención UPP, contención SOS

Cuidados de GTT - Permeabilizar

Aseo bucal 4 veces al día

Aseo ocular CAF

Levetiracetam 500 mg cada 12 horas por GTT

Paracetamol 1 g SOS si fiebre o dolor por GTT

Pasta lassar aplicar en zona del pañal cada 8 horas o al cambiar pañal

Planes:

Presentado a FLR y clínica familia, cupo autorizado para jueves 10 de noviembre en clínica familia.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Cabeza Línea Media 30°

Régimen Alimentario : Por Gastrostomía

Fecha Epicrisis : 10/11/2022 08:21

Página 3 de 4

Fecha Última Actualización: 10-11-2022 8:21:25

Página 4 de 4

Medicamentos

: Paracetamol 500mg 1 Gr Cada 8 Horas En Caso De Fiebre O Dolor Por Gastrostomia
Levetiracetam 500 Mg Cada 12 Horas Por Gastrostomia

Controles

S/F - APS - - postrados

INTERNO

Becado/Residente



Daniela Paz Fariñas Nesvadba

Médico Tratante (Staff)